Arrêts de travail : nouvelle campagne de mise sous objectifs, et SOS IJ, un téléservice pour les arrêts complexes

La rédaction du Cercle des Généralistes · 22 octobre 2026 · 12 min de lecture

SITUATION

Selon MG France, l'Assurance Maladie a annoncé le 14 octobre une nouvelle mise sous objectifs ; SOS IJ, présenté le 20 octobre, est disponible dans l'Hexagone.

Selon MG France, le directeur général de l'Assurance Maladie a présenté le 14 octobre 2026 aux syndicats une nouvelle campagne de mise sous objectifs des médecins généralistes, alors que « les procédures sont sur le point d'être lancées ». Selon la CSMF, « 650 médecins vont être contrôlés ». Au 22 octobre, l'Assurance Maladie n'a publié sur ameli.fr aucune information sur cette campagne. Le 20 octobre 2026, elle a présenté SOS IJ, un téléservice d'amelipro pour les situations complexes d'arrêt de travail, disponible dans l'Hexagone.

L'ESSENTIEL

- **Ce qui change :** selon la CSMF, une nouvelle campagne de mise sous objectifs vise 650 médecins ; SOS IJ permet de solliciter l'Assurance Maladie sur un arrêt complexe.
- **Quand :** courriers « prochainement », précédés en principe d'un appel, selon MG France ; SOS IJ présenté le 20 octobre 2026, outre-mer courant 2027.
- **Que faire :** dès l'appel de la CPAM, contacter son syndicat ; présenter ses observations dans le mois qui suit la notification, et répondre dans les 15 jours à une proposition de mise sous objectifs, faute de quoi elle est réputée acceptée.

CONTEXTE

La campagne précédente de mise sous objectifs des indemnités journalières s'est déroulée en 2 vagues, jusqu'au 30 juin 2026. Comme nous l'écrivions dans notre article du 4 juin, elle visait les médecins figurant parmi les 10 % de prescripteurs au nombre moyen d'indemnités journalières par patient actif le plus élevé, ou dont les prescriptions étaient au moins 2 fois supérieures à la moyenne. Selon MG France, le gouvernement avait renoncé en janvier, après 10 jours de grève, au projet de mise sous objectifs obligatoire, et annoncé une mission chargée d'établir un diagnostic de la procédure et de l'améliorer, notamment en transparence.

Selon l'Assurance Maladie, la mise sous objectifs est proposée au médecin en alternative à la mise sous accord préalable. S'il la refuse, la CPAM poursuit la procédure de mise sous accord préalable, qui subordonne pendant 6 mois au plus ses prescriptions d'arrêts de travail à l'accord préalable du service médical.

Pourquoi : les dépenses d'indemnités journalières sont l'une des cibles d'économies du budget de la Sécurité sociale. L'annexe du projet de loi de financement pour 2027 en attend 1 Md€ en 2027, comme nous l'écrivions dans notre dossier sur le PLFSS 2027. Selon l'Assemblée nationale, sa commission des affaires sociales a rejeté ce projet à l'issue de son examen, du 12 au 16 octobre. La discussion en séance publique est prévue du 20 au 26 octobre, et le vote solennel le 27 octobre. Selon la Cour des comptes, qui a publié le 20 octobre 2026 son analyse de la situation financière de la Sécurité sociale, le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de négocier d'ici la fin de l'année les mesures qui dégageront ces économies ; « en l'absence de succès de la négociation, le Gouvernement agira par la voie réglementaire », notamment sur le taux de remplacement, le plafond d'indemnisation ou le délai de carence. La Cour constate aussi qu'en 2026, les indemnités journalières maladie « ont fortement ralenti, notamment grâce aux mesures prises antérieurement ».

CE QUI EST CONFIRMÉ

Sur SOS IJ, l'Assurance Maladie présente le téléservice comme un « point d'entrée unique et sécurisé » pour les médecins confrontés à une situation complexe d'arrêt de travail. Il couvre 4 thématiques : les difficultés liées au poste de travail ou à l'employeur, les questions sur la prolongation de l'arrêt, les interrogations sur la poursuite des indemnités journalières, et la fragilité financière ou sociale du patient ou ses difficultés d'accès aux soins. Le médecin se connecte à amelipro, identifie le patient par sa carte Vitale ou son NIR, clique sur « SOS IJ » depuis la page d'accueil ou depuis « Contacter le médecin conseil », puis décrit la situation. Un premier retour est apporté par l'Assurance Maladie dans un délai de 48 heures. Si le patient peut être accompagné, le médecin doit l'informer de la démarche. Le service est disponible dans l'ensemble de l'Hexagone ; sa généralisation aux départements et régions d'outre-mer est prévue courant 2027.

Sur la campagne, ce que l'on sait vient des syndicats. MG France écrit que le directeur général de l'Assurance Maladie l'a annoncée le 14 octobre aux syndicats médicaux, et que les courriers partiront prochainement, « précédés en principe d'un appel téléphonique ». La CSMF écrit le 15 octobre que « 650 médecins vont être contrôlés dans le cadre d'une nouvelle campagne MSO/MSAP lancée par les CPAM », et Les Généralistes-CSMF, le 20 octobre, qu'ils le seront « dans les semaines qui viennent ». La CSMF conseille au médecin ciblé d'agir dès l'appel : « Dès réception d'un appel téléphonique de votre CPAM, contactez un représentant de la CSMF de votre département », pour « analyser vos statistiques, prendre en compte les particularités de votre patientèle », préparer ses observations et défendre son exercice. MG France propose aussi d'accompagner les médecins ciblés qui le demandent.

Sur la procédure, le code de la sécurité sociale fixe les règles. Selon son article L. 162-1-15, la caisse peut viser le médecin dont le nombre ou la durée des arrêts de travail prescrits, ou leur nombre rapporté au nombre de patients, est « significativement » supérieur aux données moyennes constatées « pour une activité comparable » chez les médecins de la même agence régionale de santé ou de la même caisse. Selon l'article R. 148-1, le directeur de la caisse notifie au médecin les données chiffrées de sa pratique et celles de la moyenne qui sert de référence ; le médecin peut, dans le mois qui suit, demander à être entendu, en se faisant assister par la personne de son choix, ou présenter ses observations écrites. Le directeur décide ensuite dans le mois d'abandonner la procédure, de proposer une mise sous objectifs ou d'engager la mise sous accord préalable ; s'il ne statue pas dans ce délai, la procédure est réputée abandonnée.

Selon l'article R. 148-3, la proposition de mise sous objectifs fixe un objectif qui ne peut être inférieur à la moyenne de référence, une période de 4 à 6 mois pour l'atteindre et le montant maximum de la pénalité encourue en cas de dépassement. Le médecin peut la refuser par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours qui suivent la notification ; faute de réponse dans ce délai, il est réputé l'avoir acceptée. En cas de refus, la caisse poursuit la procédure de mise sous accord préalable et saisit une commission, devant laquelle le médecin peut demander à être entendu ou présenter ses observations écrites dans le mois. Si l'objectif n'est pas atteint, le directeur peut engager une procédure de pénalité, au cours de laquelle le médecin exerce ses droits de la défense.

Sur l'indemnisation, selon Service Public, la durée maximale d'indemnisation passe de 3 ans à 1 an depuis le 15 octobre 2026 pour une affection suffisamment sévère pour justifier un arrêt de plus de 6 mois, qui ne découle ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle, ni d'une affection de longue durée (ALD), comme l'expliquait notre article sur la durée dérogatoire des arrêts de travail. Les assurés déjà arrêtés depuis plus de 6 mois au 15 octobre 2026 restent soumis à l'ancienne règle, avec 3 ans d'indemnisation au plus.

CE QUI POSE QUESTION

Au 22 octobre 2026, 4 questions restent ouvertes.

La nouvelle campagne reprend-elle les critères de la précédente ? L'Assurance Maladie n'a rien publié sur cette campagne, et l'article L. 162-1-15 exige une comparaison « pour une activité comparable » sans préciser comment la caisse la mesure. MG France écrit qu' « on constate une absence de réelle transformation de la méthode », qu'il juge « peu rigoureuse sur le plan statistique », et demande comment l'Assurance Maladie « peut tolérer de se tromper une fois sur quatre », sans préciser à quoi renvoie ce chiffre.

Un arrêt signalé dans SOS IJ sera-t-il retiré du calcul qui sert à cibler le médecin ? SOS IJ porte notamment sur des arrêts prolongés par le poste, l'employeur ou la situation sociale du patient, qui pèsent sur le nombre moyen d'indemnités journalières par patient, critère de la campagne précédente. Rien de ce qu'a publié l'Assurance Maladie ne relie les 2 dispositifs.

Que deviennent les informations transmises dans SOS IJ ? L'Assurance Maladie indique que ses « experts » répondent et qu'il est « nécessaire » de tenir le patient informé de la démarche. Elle ne dit rien de l'accord du patient, du secret médical, de l'usage qui sera fait des informations transmises, ni d'une rémunération du temps passé par le médecin.

Quand les courriers partiront-ils ? MG France écrit « prochainement » ; Les Généralistes-CSMF annoncent les contrôles « dans les semaines qui viennent ». L'Assurance Maladie n'a publié aucun calendrier.

L'IMPACT FINANCIER & ORGANISATIONNEL

Pour le cabinet, 2 choses changent.

Le médecin ciblé a peu de temps. Selon MG France, « les délais sont courts et la procédure difficile à vivre ». Une mise sous accord préalable alourdit chaque arrêt : selon l'Assurance Maladie, la prescription attend l'accord préalable du service médical, et l'assuré reçoit un courrier qui le prévient des conditions particulières de prise en charge. Selon le code de la sécurité sociale, le médecin a 1 mois pour présenter ses observations, puis 15 jours pour refuser une proposition de mise sous objectifs ; s'il ne répond pas, elle est réputée acceptée, avec la pénalité dont elle indique le montant maximum si l'objectif n'est pas atteint.

SOS IJ donne enfin un interlocuteur pour les situations complexes d'arrêt de travail : des difficultés liées au poste ou à l'employeur, une fragilité financière ou sociale du patient. Le premier retour est promis sous 48 heures. L'outil tombe à point : selon Service Public, la durée maximale d'indemnisation des arrêts longs hors ALD, accident du travail et maladie professionnelle est désormais de 1 an, et la question de la poursuite des indemnités journalières, que couvre SOS IJ, se posera donc plus tôt pour ces patients.

LE REGARD DU CERCLE

L'Assurance Maladie envoie 2 messages contraires la même semaine. Avec SOS IJ, elle reconnaît que certains arrêts se prolongent pour des raisons qui ne relèvent plus du soin : un poste de travail qui pose problème, des difficultés avec l'employeur, une fragilité sociale ou financière. Avec la mise sous objectifs, elle cible les médecins sur une statistique qui, lors de la campagne précédente, comptait ces mêmes arrêts. SOS IJ est une bonne nouvelle, et il faut s'en servir ; mais tant que ces arrêts pèsent dans le calcul qui désigne les médecins contrôlés, le généraliste qui suit les situations les plus difficiles reste le plus exposé. La loi demande pourtant de le comparer aux médecins qui ont « une activité comparable ».

La campagne arrive aussi à contretemps. Selon la Cour des comptes, les indemnités journalières maladie ont déjà « fortement ralenti » en 2026, et les économies attendues en 2027 doivent venir d'une négociation entre partenaires sociaux ou, à défaut, de mesures réglementaires sur le taux de remplacement, le plafond d'indemnisation ou le délai de carence. Les économies se joueront donc sur les règles d'indemnisation, bien plus que sur les prescriptions de quelques centaines de médecins. L'une d'elles a d'ailleurs déjà changé le 15 octobre : selon Service Public, la durée maximale d'indemnisation de certains arrêts longs est passée de 3 ans à 1 an. Contrôler les 650 médecins annoncés par la CSMF sans publier de critères, alors que le « travail de transparence et d'amélioration du dispositif » promis en février n'a pas eu lieu selon MG France, revient à conserver la méthode que MG France conteste : « une méthode qui juge un médecin sur un écart statistique, sans regarder les raisons pour lesquelles ses patients sont arrêtés ».

Avant le premier courrier, l'Assurance Maladie devrait publier sa méthode, retirer de son calcul les arrêts signalés dans SOS IJ et dire ce que deviennent les informations qui y sont transmises : un médecin reçoit ses chiffres et la moyenne de référence, et peut les expliquer, mais il ne peut pas se défendre contre une méthode de ciblage qu'il ne connaît pas.

RECOMMANDATIONS

- **Médecin généraliste qui prescrit des arrêts longs** : Saisir SOS IJ, après en avoir informé le patient, pour chaque arrêt prolongé par le poste, l'employeur ou une fragilité sociale, et noter dans le dossier du patient la date de la demande et celle de la réponse, pour pouvoir les produire si sa CPAM le contacte.

- **Médecin contacté par sa CPAM** : Contacter son syndicat dès l'appel de la caisse, sans attendre le courrier, puis tenir les 2 délais du code de la sécurité sociale : 1 mois après la notification pour présenter ses observations, en justifiant patient par patient ses arrêts longs (pathologie, poste,

employeur, demandes faites dans SOS IJ), et 15 jours pour refuser par lettre recommandée une proposition de mise sous objectifs, au vu du montant maximum de pénalité qu'elle indique, son silence valant acceptation.

Sources

Assurance Maladie, SOS IJ : un nouvel outil de l'Assurance Maladie au service des médecins (20 octobre 2026)

Cour des comptes, La situation financière de la sécurité sociale : un redressement impératif en 2027 (20 octobre 2026)

Assurance Maladie, Les contrôles possibles dans le cadre d'un arrêt de travail (mise à jour le 26 mars 2026)

Code de la sécurité sociale, articles L. 162-1-15 et R. 148-1 à R. 148-9 (version à jour au 22 octobre 2026)

Service Public, arrêts maladie : baisse de la durée d'indemnisation de certains arrêts longs (mise à jour le 20 octobre 2026)

Assemblée nationale, commission des affaires sociales, projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 : examen du projet de loi en commission

Assemblée nationale, organisation de la discussion budgétaire (29 septembre 2026)

MG France, Nouvelle campagne MSO, engagements trahis (14 octobre 2026)

MG France, MSO, ça recommence : appuyez-vous sur MG France (15 octobre 2026)

CSMF, Flash Info Arrêts de travail (15 octobre 2026)

Les Généralistes-CSMF, Lettre hebdo n° 1055 du 20 octobre 2026

Traçabilité : Assurance Maladie (ameli.fr) ; Cour des comptes, communication du 20 octobre 2026 à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, pages 15 et 24 ; Service Public ; Assemblée nationale (commission des affaires sociales, organisation de la discussion budgétaire) ; code de la sécurité sociale, articles L. 162-1-15 et R. 148-1 à R. 148-9, lus dans leur version à jour au 22 octobre 2026 ; MG France ; CSMF ; Les Généralistes-CSMF. L'Assurance Maladie n'ayant publié sur ameli.fr aucune information sur la campagne, les syndicats sont cités pour ce qu'ils en rapportent et pour leurs positions, toujours attribuées.